

表 6 蓝靛果果汁对小鼠 5-FU 后
生存率的影响($\bar{X} \pm S$)

组别	只数	10 天后存活只数	存活率(%)
盐水组	10	3	30
果汁组	10	7	70**
阿胶组	10	5	50

与盐水组比较, ** 表示 $P < 0.01$ 。

3 讨论

从我们的实验结果表 1 和表 2 反映出, 在使用蓝靛果果

汁后, 小鼠的白细胞下降程度与盐水对照组比较有显著差异 ($P < 0.01$) 且对不同化疗药物(烷化剂、抗嘧啶药)均有显著差异。揭示蓝靛果可从不同途径减缓白细胞减少。实验结果表 3 和表 4 表明, 在使用化疗药同时, 给蓝靛果 7 天后, 果汁组与盐水组比, 体重下降程度有显著差异 ($P < 0.01$), 果汁组能明显缓解小鼠体重减轻。从表 5 和表 6 看, 果汁组与盐水组比生存率存在显著差异 ($P < 0.01$) 说明, 蓝靛果可明显提高化疗后小鼠生存率。提示该果汁可作为肿瘤化疗时, 减缓化疗药物副反应, 提高生存质量和生存率的辅助药品。

纤维瘤病 20 例治疗报告

郝 刚 高 平

摘要 目的 探讨纤维瘤病的临床特点和治疗方法。方法 回顾分析我院 1982~2000 年间外科收治的 20 例纤维瘤病, 其中腹壁纤维瘤病 15 例, 腹壁外纤维瘤病 5 例。结果 本组 20 例纤维瘤病都采用手术治疗, 辅以糖皮质激素局部注射。合并内分泌治疗 5 例, 放疗 2 例, 都未见复发。结论 纤维瘤病呈侵袭性生长, 复发率高, 广泛手术切除是主要方法, 辅以糖皮质激素、放疗、内分泌治疗是减少复发的有效方法。

关键词 纤维瘤病 手术

我院自 1982~2000 年共收治纤维瘤病 20 例, 现报道如下。

1 临床资料

本组女性 16 例, 男性 4 例。就诊年龄 18~76 岁, 平均为 35.8 岁。肿瘤位于腹壁者 15 例(左、右上腹壁各 2 例, 右下腹壁 7 例, 左下腹壁 4 例), 肢体 5 例(股部 3 例, 上臂 1 例, 手掌 1 例)。腹壁 15 例中 13 例为首发病例, 2 例为复发病例; 肢体 5 例中 2 例为首发病例, 3 例为复发病例。病程最短者为 1 个月, 最长者达 5 年, 平均 11.6 月。肿瘤大小: 直径 2.5cm 2 例, 2.5~5.0cm 12 例, 5.0~10.0cm 6 例。

本组 20 例中 19 例无明显外伤史, 仅 1 例肿瘤位于股前的 76 岁男性患者, 其股部曾有猛烈扭伤史。16 例女性病例皆为育龄期妇女, 其中 14 例有生育史, 仅 2 例无生育史。本组病例中仅 3 例肿块处有隐痛感, 其余 17 例无痛。5 例复发病例中, 曾于外院行 1 次手术后复发者 2 例, 行 2 次手术后复发者 2 例, 行 3 次手术后复发者 1 例。

2 治疗方法

本组病例均采用手术治疗, 术后全部辅以糖皮质激素局部注射治疗, 部分辅助放疗。5 例复发病例最后都加服三苯氧胺治疗。

3 随访结果

除 1 例腹壁纤维瘤病患者因移居外地而失访外, 其余 19 例均随访至 2002 年 3 月, 随访率为 95%, 均治愈而未复发或不再复发。

4 讨论

以往所谓的硬纤维瘤(DESMOID TUMOR), 又称韧带样瘤, 简称韧带瘤, 现认为属于纤维瘤病(FIBROMATOSIS)或侵袭性纤维瘤病(AGGRESSIVE FIBROMATOSIS); 最近世界卫生组织新的组织学分型定为腹壁纤维瘤病及腹壁外纤维瘤病。发病率约占软组织肿瘤的 0.03%, 是一种较为少见的来源于纤维结缔组织的交界性软组织肿瘤^[1]。好发于育龄期女性的腹壁, 尤其是下腹壁。其病因还不十分清楚, 可能与女性激素平衡失调及妊娠时的腹壁肌肉撕拉损伤致成纤维母细胞增生有关^[2]。纤维瘤病的临床表现以定位较深的无痛性肿块为主, 病程较长, 发展较慢, 多数病人待肿瘤较大后方就诊。

本病治疗以手术治疗为主, 尤其是腹壁外纤维瘤病为侵袭性生长的肿瘤, 具有强烈的局部复发倾向^[3]。手术应严格遵守软组织肿瘤广泛切除的治疗原则, 即真正做到三维空间距肿瘤 2~3cm 的广泛切除, 尤其是长轴方向上切除更要广泛^[4]。术中配合肿瘤切除冰冻切片检验, 必要时随时扩大切除范围, 这对防止纤维瘤病术后复发有极其重要的意义。腹壁部位的纤维瘤病要求深达腹膜, 必要时连同腹膜一并整块切除。本组有 1 例右下腹壁纤维瘤病因肿块较大, 切除后腹壁缺损巨大, 术中切取同侧股部阔筋膜移植修补, 获得满意效果。

本组四分之一的病例曾 1 次或多次手术后复发, 大多为腹壁外纤维瘤病, 除肢体肿瘤其生物特性更具侵袭性外, 可能因肿瘤紧贴重要血管、神经, 以致难以达到三维空间的广泛切除有关。

作者单位: 200032 上海市徐汇区日晖医院

术后辅助治疗:糖皮质激素、三苯氧胺、放疗都有一定疗效^[5,6]。根据糖皮质激素具有抗纤维母细胞增生的作用,本组病例皆在局部广泛切除的基础上辅以激素局部注射,一般我们在皮肤创口拆线后 3 天既开始应用确炎舒松 1ml+1%利多卡因 5~10ml 直接注射于原来瘤术床部位,每周 1 次,共注射 4 次。

雌激素受体拮抗剂三苯氧胺能与雌激素竞争性结合雌激素受体。本组中 5 例复发病例同时应用三苯氧胺后皆未再发。其中 1 例 18 岁男性患者,其股后肿瘤与坐骨神经贴邻,曾 3 次在外院及我院手术而复发,1992 年 12 月第 4 次在我院将肿瘤切除。术后除放疗等外,还辅以三苯氧胺治疗(每次 100mg,每日 2 次,连服 2 年),随访 9 年余未再复发。另 1 例中年女性患者,肿瘤位于上臂,第 1 次手术后 8 个月复发,第 2 次手术时发现肿瘤与肱骨骨膜紧密粘连,术中用电刀将肿瘤连同部分肱二头肌及牵连的肱骨骨膜一并整块切除,术后辅以放疗及三苯氧胺内服,随访 10 年余未再复发。切除时,

只要血管钳尚能向血管神经鞘深面深入,尚可用电刀切开后加以剥离切除者,不考虑行截肢手术,术后辅以放疗及三苯氧胺治疗,仍能获得满意的效果。

参考文献

- 1 Rodriguez - Bigas MA, Mahoney Mc, Karakousis cp, et al. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis. Cancer, 1994, 74: 1270-1274.
- 2 汤钊猷. 现代肿瘤学, 第 1 版, 上海, 上海医科大学出版社, 1993, 1033.
- 3 R. coper 硬纤维瘤诊断和处理. 国外医学外科分册, 1990, 17: 355.
- 4 杨维良, 聂刚, 朱江. 腹壁硬纤维瘤 45 例报告. 中国实用外科杂志, 1997, 17: 337.
- 5 Benninghoff D, Robbins R. The nature and treatment of desmoid tumors. AJR, 1964, 91: 132.
- 6 蔡三军, 李澎, 李月云. 61 例腹壁带状瘤处理. 肿瘤, 1990, 11: 226.

中学生错颌畸形情况调查分析

郭丽华 郭丽东 李婷婷

摘要 目的 了解哈尔滨市南岗区中学生错颌畸形情况, 并且有计划地对其进行防治。方法 对哈尔滨市南岗区 1250 名中学生错颌畸形情况进行调查。结果 中学生错颌患病率较高。结论 哈尔滨市南岗区中学生错颌患病率较高, 提示有必要加强错颌畸形的早期矫治和防治知识的普及。

关键词 错颌 调查

为了了解哈尔滨市南岗区中学生错颌畸形情况, 并且有计划地对其进行防治, 作者对哈尔滨市南岗区 1250 名中学生的错颌畸形情况作了调查, 现将结果报告如下。

1 对象和方法

1.1 调查对象: 1250 名调查对象中, 男 705 名, 女 545 名, 年龄 12~17 岁。

1.2 方法: 本检查采用室内自然光线, 采用探、视、问诊进行检查, 并填写检查结果。

1.3 标准: 根据付民魁主编的《口腔正畸学》^[1]中错颌畸形检查方法进行调查, 将其分为正常颌和错颌两类, 采用“个别正常颌”作为关系正常标准。对每个错颌患者同时采用安氏分类法, 并且按临床表现分类, 对含有多种错颌畸形病例只统计较严重的一种症状, 共分为牙列拥挤、个别牙错位、深覆颌、牙齿前突、反颌、对刃颌、开颌、锁颌, 前牙散在间隙 9 项。

2 结果

2.1 错颌患病率: 1250 名中学生中错颌者 597 名, 患病率为 47.73%, 其中男性患病率为 48.80%, 女性患病率为

46.76%, 男性略高于女性, 经 X^2 检验, $P > 0.05$, 无显著性差异, 见表 1。

表 1 错颌患病率

性别	受检人数	错颌人数	患病率(%)
男	705	343	48.80
女	545	254	46.66
合计	1250	597	47.73

2.2 错颌的安氏分类患病率: 根据安氏分类法其中一侧中性关系均按另一侧远中或近中关系分类记录, 597 名错颌畸形患者中, 其各种畸表所占比例见表 2。

表 2 错颌分类患病率

性别	安氏 I 类	安氏 II 类	安氏 III 类
错颌人数	307	115	175
发病率(%)	51.48	19.32	29.20

2.3 各类错颌所占比例: 按发病率中由高至低分为: 牙齿拥挤、反颌、深覆颌、牙齿前突、个别牙错位、前牙散在间隙、对刃颌、锁颌、开颌。各种错颌 $P < 0.05$ 的发病率男性高

作者单位: 150038 哈尔滨纺织印染厂医院口腔科